

« Ebola ne respecte pas les frontières » : en RDC, une souche inédite du virus complique la riposte sanitaire (jeune afrique)

C'est un nouveau variant qui a fait son apparition dans l'est de la RDC, pour lequel il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement. Comment a-t-il pu se propager pendant plusieurs semaines sans que personne ne s'en rende compte ? Quelle est sa létalité et que risquent les pays voisins ? Jeune Afrique fait le point.



Un personnel du Laboratoire Rodolphe Mérieux de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Goma, le 19 mai. © JOSPIN MWISHA / AFP

Par [Stanis Bujakera Tshiamala](#)

Publié le 19 mai 2026

Modifié le 20 mai 2026 à 11h23

Lecture : 8 minutes.

Les autorités [congolaises](#) parviendront-elles à enrayer cette nouvelle flambée épidémique ? Pendant plus de trois semaines, le virus Ebola a voyagé silencieusement à travers la province de l'Ituri avant d'atteindre les villes de Goma et de Butembo, dans le Nord-Kivu, et de traverser la frontière qui sépare l'est de la RDC de l'[Ouganda](#).

Le 15 mai, après confirmation par l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), l'épidémie a été officiellement déclarée et, dès le lendemain, [l'Organisation mondiale de la santé \(OMS\) l'a classée comme « urgence de santé publique de portée internationale »](#), son deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Mais la découverte d'une souche génétiquement inédite (la souche Bundibugyo) menace de compliquer la riposte sanitaire, tout comme les graves problèmes de sécurité auxquels sont confrontées les provinces de l'Est, où les déplacements de population favorisent la circulation du virus. Voici ce que l'on sait, à ce stade, de l'apparition et de la progression de cette nouvelle épidémie.

● Le patient zéro identifié ?

Tout commence le 24 avril à Bunia, en Ituri. Un infirmier congolais développe fièvre, fatigue et vomissements. C'est le premier cas documenté à ce stade. L'une de ses proches tombe malade deux jours plus tard, et tous deux succombent fin avril.

Personne n'alerte les autorités. Localement, ces décès sont attribués au « tumu », une sorte de malédiction. « Ils ont cru que c'était mystique. Ils appelaient ça le “phénomène cercueil” », a expliqué le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba.

Comme il est d'usage en pareilles circonstances, les corps sont veillés, touchés, embrassés. Celui de l'infirmier est rapatrié à Mongwalu, ville minière située à 80 km de Bunia, où les mêmes rites se répètent. Le [Centre africain de contrôle et de prévention des maladies \(Africa CDC\)](#) estimera plus tard qu'il y a eu au total quatre semaines de transmission non contrôlée. À Mongwalu, 15 membres d'une seule et même famille sont décédés.

● Un bilan lourd... mais incertain

À ce jour, cette 17^e épidémie à virus [Ebola](#) officiellement recensée en RDC aurait déjà fait plus de 130 victimes. « Nous avons comptabilisé 131 décès dans les zones affectées, mais tous ne sont pas nécessairement liés à Ebola, modère Samuel Roger Kamba. Ce sont des décès suspects et nous vérifions lesquels sont effectivement liés à la maladie. » Par ailleurs, 513 cas suspects ont été répertoriés.

Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC, a prévenu que les chiffres étaient encore « très provisoires » et que le bilan allait « changer au jour le jour ». Jean-Jacques Muyembe, co-découvreur du virus Ebola, estime pour sa part qu'il « circule [déjà] dans la population ». Pour l'instant, l'épidémie touche plusieurs zones en Ituri, mais aussi dans le Nord-Kivu.

● Une propagation déjà transfrontalière

Un Congolais de 59 ans a quitté l'Ituri pour Kampala. Hospitalisé le 11 mai, il est décédé le 14. Sa dépouille a été rapatriée le jour même en RDC pour y être enterrée.

Jean Kaseya s'est inquiété des conséquences de ce périple. « Qui a voyagé avec lui ? Qui l'a soigné en Ouganda ? Qui a ramené le corps ? Comment l'enterrement a-t-il été organisé ? Nous sommes devant des situations où la transmission doit être assez importante », a-t-il alerté. L'OMS a néanmoins déconseillé de fermer les frontières : de telles mesures « n'ont aucune base scientifique », estime-t-elle, et risquent paradoxalement d'aggraver la propagation.

À Kampala, où deux autres cas ont été confirmés, le président [Yoweri Museveni](#) a annoncé, le 17 mai, le report des célébrations religieuses de la Journée des martyrs, qui attirent chaque année des milliers de pèlerins. Il a invité les fidèles déjà en route à rentrer chez eux et à signaler tout cas suspect aux autorités sanitaires.

● Un médecin américain contaminé à Bunia

Il s'agit du Dr Peter Stafford, médecin missionnaire américain travaillant à l'hôpital de Nyankunde, à Bunia, pour l'organisation chrétienne Serge – sa contamination a été confirmée le 18 mai.

Premier ressortissant américain testé positif depuis le début de l'épidémie, il a été exposé en traitant des patients dans la zone affectée. Son épouse, le Dr Rebekah Stafford, et un de leurs collègues, le Dr Patrick LaRochelle, demeurent asymptomatiques et respectent strictement les protocoles de quarantaine.

Ce cas illustre le niveau de risque auquel sont exposés les soignants, alors que quatre agents de santé congolais sont déjà décédés depuis le début de l'épidémie.

● À Goma, un seul cas confirmé

Un cas a été confirmé dans la [capitale provinciale du Nord-Kivu contrôlée par les rebelles de l'AFC/M23 depuis janvier 2025](#). Il s'agit d'une femme dont le mari est décédé à Bunia.

Dans un communiqué daté du 18 mai, la rébellion a fait état de 189 cas contacts identifiés à Goma par les équipes sanitaires déployées sur le terrain. Le même jour, 22 échantillons ont été envoyés à l'INRB pour analyse : parmi les résultats déjà disponibles, 5 se sont révélés négatifs, les autres étant encore en attente.

Plus au sud, à Bukavu, ville elle aussi contrôlée par la rébellion, un cas suspect a été signalé, mais l'échantillon acheminé à Goma pour analyse s'est avéré négatif. L'[AFC/M23](#) affirme qu'à ce stade aucun nouveau cas n'a été enregistré dans les zones qu'elle administre.

Cet effort de communication n'occulte toutefois pas le fait que l'absence de coordination entre Kinshasa et Goma pose de véritables problèmes. Chaîne de commandement sanitaire, protocoles de notification, acheminement des équipements, gestion des données épidémiologiques dans une zone non contrôlée par le gouvernement central... Aucun de ces points n'a pour l'instant de réponse opérationnelle claire. Le fait que l'aéroport de Goma, endommagé lors de la conquête de la ville, soit toujours fermé aggrave encore la situation.

● L'insécurité profitera-t-elle à Ebola ?

Officiellement placée sous état de siège, [la province de l'Ituri est en proie à la violence des groupes armés que sont les ADF](#), la Codeco, le groupe Zaïre ou la CRP. Tous ont déjà provoqué des déplacements massifs de populations, ce qui est précisément le vecteur de propagation le plus redouté.

« L'insécurité complique tous les piliers de la réponse : l'accès aux zones affectées, le transport des échantillons, le suivi des contacts, l'isolement précoce, l'enterrement digne et sécurisé », résume Jean Kaseya. Jean-Jacques Muyembe fait pour sa part le parallèle avec la flambée épidémique de 2018-2020 : il s'agit encore une fois de « gérer une épidémie dans une zone de conflit ».

● Une souche inédite, venue de la forêt

C'est l'élément qui change tout ou presque. Après séquençage complet, Jean-Jacques Muyembe a confirmé que la souche identifiée en Ituri n'était apparentée ni au Bundibugyo ougandais de 2007 ni à celui d'Isiro, en 2012. « C'est une souche tout à fait nouvelle qui vient de la forêt et est entrée en circulation dans la communauté humaine », a-t-il déclaré. Les chercheurs doivent donc repartir de zéro dans l'identification d'éventuels vaccins ou de molécules thérapeutiques.

Une précision atténue toutefois l'inquiétude. Sur le plan de la létalité, celle-ci reste moins meurtrière. « Avec Bundibugyo, la mortalité est autour de 30 %. Tandis qu'avec la souche Zaïre, vous avez une mortalité qui dépasse les 80 % », rappelle Jean-Jacques Muyembe. Un mort sur trois correspond néanmoins à un niveau de létalité considérable.

Pour l'instant, la riposte repose sur les seules mesures de santé publique. « Cela ne veut pas dire que lorsqu'il n'y a pas de vaccin, on ne peut plus rien faire, insiste Samuel Roger Kamba. Diagnostiquer très rapidement, c'est

une mesure aussi importante qu'avoir un vaccin. » Jean-Jacques Muyembe rappelle d'ailleurs que 15 des 17 épidémies congolaises ont été maîtrisées sans vaccin ni traitement. « Le peuple congolais peut avoir confiance : nous avons des experts », a-t-il ajouté.

● Une défaillance dans la détection

Si plusieurs semaines se sont écoulées entre les premiers symptômes et la confirmation officielle, c'est en partie parce que les 42 laboratoires déployés par Africa CDC à travers la RDC sont équipés de machines configurées pour détecter exclusivement la souche Ebola Zaïre. Il a donc fallu que les échantillons soient envoyés à l'INRB, à Kinshasa, où la confirmation d'une nouvelle souche a pu être faite. Sur 13 échantillons analysés, 8 étaient positifs.

« Notre système de surveillance n'a pas fonctionné », a reconnu Jean-Jacques Muyembe. « Dans cette région, vous avez des députés, des sénateurs qui vont en vacances et qui sont au courant. Ils savent qu'il y a des morts et on ne dit rien. C'est l'irresponsabilité de tous ! » s'est-il aussi indigné. Le ministre Roger Kamba a pour sa part défendu le gouvernement en invoquant « la règle 7-1-7 » : il faut « être alerté dans les sept jours, intervenir immédiatement et poser le diagnostic rapidement. Et c'est ce qui a été fait ».

● Félix Tshisekedi réunit une cellule de crise

Preuve que Kinshasa prend la situation très au sérieux, le chef de l'État, [Félix Tshisekedi](#), a présidé lundi 18 mai une réunion de crise consacrée à la gestion de l'épidémie. Espérant enrayer sa progression, le gouvernement a appelé les populations des zones affectées à renoncer aux rites funéraires traditionnels et à adopter des pratiques d'enterrement sécurisées.

Roger Kamba a également demandé de respecter certaines consignes en matière d'habitudes alimentaires : « C'est une maladie qui vient d'un animal. Ne pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans les zones à risque. »

● Les alertes se multiplient, Washington prend peur

Alors que l'OMS a convoqué ce mardi une réunion d'urgence à Genève, le Burundi, le Kenya et le [Nigeria](#) ont renforcé leurs contrôles sanitaires aux différents points d'entrée sur leur territoire. Le Soudan du Sud est quant à lui en alerte prioritaire et Kigali a renforcé le dépistage à ses frontières, sans cas recensé à ce jour. Le président sud-africain, [Cyril Ramaphosa](#), a lancé un avertissement solennel : « Ebola ne respecte pas les frontières. Le risque de propagation régionale est significatif et demande une action urgente et coordonnée. »

Les États-Unis ont annoncé, le 18 mai, des restrictions d'entrée sur leur territoire visant les ressortissants non américains ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents en invoquant le *Public Health Service Act*. Une mesure qui contraste avec la position de l'OMS, opposée à toute restriction aux frontières. Washington a par ailleurs annoncé une enveloppe de 13 millions de dollars pour soutenir la riposte.

L'Africa CDC avait auparavant réuni ses partenaires et dit avoir besoin de 30 millions de dollars.